

Accidente Cerebrovascular Isquémico y Hemorrágico

1. Introducción y relevancia clínica

El **accidente cerebrovascular (ACV)**, también conocido como **enfermedad cerebrovascular (ECV)**, constituye una de las principales causas de **mortalidad y discapacidad en el mundo**. En Chile, el ACV ocupa el **primer lugar como causa de muerte en adultos mayores** y es una causa relevante de dependencia funcional, con una incidencia aproximada de **120 casos por 100.000 habitantes** (MINSAL, 2023).

Se define como un **déficit neurológico focal de inicio súbito, secundario a una alteración del flujo sanguíneo cerebral**, que puede ser **isquémica (85%)** o **hemorrágica (15%)**.

La importancia del ACV radica en su **alta morbilidad, impacto socioeconómico y posibilidad de prevención y tratamiento efectivo** si se reconoce precozmente. El concepto de **“tiempo es cerebro”** resume la urgencia del diagnóstico y la intervención.

En el contexto del **EUNACOM**, este tema integra conocimientos de urgencia, semiología neurológica, fisiopatología, manejo agudo y prevención secundaria —elementos claves de la práctica médica general en Chile.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. ACV isquémico

El **ACV isquémico** ocurre por una **interrupción del flujo sanguíneo cerebral**, lo que genera hipoxia y necrosis tisular.

Las principales causas son:

1. **Trombosis arterial (50%)**: por aterosclerosis de grandes vasos, especialmente en arterias carótidas o vertebrales.
2. **Embolia (30%)**: de origen cardíaco (fibrilación auricular, infarto reciente, valvulopatías).
3. **Oclusión de pequeños vasos (lacunar) (20%)**: por lipohialinosis en hipertensos o diabéticos.

La isquemia cerebral produce una **zona central de necrosis irreversible (núcleo isquémico)** y una **zona penumbra isquémica**, potencialmente recuperable si se restaura el flujo dentro de las primeras horas (ventana terapéutica de 4,5 horas para trombólisis).

2.2. ACV hemorrágico

Se debe a la **ruptura de un vaso sanguíneo intracerebral** con extravasación de sangre en el parénquima o espacios meníngeos.

Tipos:

- **Hemorragia intracerebral (HIC):** sangrado dentro del parénquima cerebral.
- **Hemorragia subaracnoidea (HSA):** sangrado en el espacio subaracnoideo, generalmente por ruptura de un aneurisma.

El daño neurológico proviene del efecto de masa, aumento de presión intracraneana (PIC) y toxicidad del plasma extravasado.

2.3. Factores de riesgo comunes

Modificables:

- Hipertensión arterial (principal factor).
- Diabetes mellitus.
- Dislipidemia.
- Fibrilación auricular.
- Tabaquismo, alcohol, obesidad, sedentarismo.

No modificables:

- Edad avanzada.
 - Sexo masculino.
 - Antecedentes familiares o genéticos.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

El cuadro clínico del ACV se caracteriza por un **déficit neurológico focal súbito**, de segundos o minutos, dependiendo del territorio afectado.

3.1. Síntomas de alarma (“FAST”)

Reconocidos internacionalmente para el diagnóstico rápido:

- **F** (Face): desviación de la comisura labial o asimetría facial.
- **A** (Arm): debilidad o caída de un brazo.
- **S** (Speech): alteración del lenguaje (disartria o afasia).
- **T** (Time): tiempo es cerebro — acudir de inmediato a urgencias.

Otros síntomas frecuentes:

- Hemiparesia o hemiplejía.
- Pérdida súbita de sensibilidad en una mitad del cuerpo.
- Alteraciones visuales (amaurosis fugaz, hemianopsia).
- Vértigo, ataxia o diplopía (síndromes vertebrobasilares).
- Disartria, disfagia, confusión o alteración del nivel de conciencia.

3.2. Semiología según territorio vascular

Arteria cerebral media (ACM):

- Hemiparesia y hemihipoestesia contralateral (cara y brazo > pierna).
- Afasia (si hemisferio dominante).
- Hemianopsia homónima.

Arteria cerebral anterior (ACA):

- Déficit motor y sensitivo en pierna contralateral.
- Alteraciones conductuales y esfinterianas.

Arteria cerebral posterior (ACP):

- Hemianopsia homónima, amnesia, agnosia visual.

Territorio vertebrobasilar:

- Diplopía, disartria, disfagia, ataxia, hemiparesia alterna, coma.

ACV lacunar (pequeños vasos):

- Hemiparesia pura o disartria-mano torpe, sin alteración de conciencia ni lenguaje.
-

3.3. Diagnóstico diferencial

- Auras epilépticas o crisis parciales.
- Hipoglicemia.
- Migraña con aura.
- Tumores cerebrales.
- Abscesos o encefalitis.
- Intoxicaciones.

Comentario EUNACOM:

En preguntas tipo caso, cuando el déficit es súbito, focal y sin fiebre ni crisis, la respuesta correcta suele ser “ACV isquémico en estudio”.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Diagnóstico de ACV

Todo paciente con sospecha de ACV requiere evaluación urgente con **imagen cerebral sin contraste** (TAC o RM).

Objetivos de la imagen:

1. Confirmar diagnóstico.
2. Diferenciar ACV isquémico vs hemorrágico.
3. Excluir otras causas (tumores, abscesos).

TAC de cerebro sin contraste:

- **Normal en las primeras horas** del ACV isquémico.
- Hiperdensidad o borramiento de surcos en infartos extensos.
- **Hemorragia intracerebral:** hiperdensidad evidente.

RM cerebral (difusión):

- Detecta isquemia en minutos (más sensible).

4.2. Estudios complementarios

- **Glicemia capilar inmediata:** descartar hipoglicemia (imitador).
- **Hemograma, coagulación, electrolitos, creatinina:** evaluar contraindicaciones a trombólisis.
- **ECG:** buscar fibrilación auricular o infarto asociado.
- **Ecocardiograma y Doppler de carótidas:** identificar fuente embolígena o estenosis.

4.3. Criterios diagnósticos de ACV

1. **Inicio súbito de déficit neurológico focal.**
2. **Duración >24 horas** o evidencia radiológica de infarto o hemorragia.

3. Exclusión de causas no vasculares.

Si los síntomas se resuelven completamente antes de 24 horas, se denomina **AIT (accidente isquémico transitorio)**.

5. Tratamiento (según Guía MINSAL 2023 y AHA/ASA 2024)

5.1. Manejo inicial general (todo paciente con ACV agudo)

1. **Evaluación ABC (vía aérea, ventilación, circulación).**

- Mantener oxigenación >94%.
- Evitar hipercapnia.

2. **Monitoreo:**

- Control de glicemia (mantener entre 140–180 mg/dL).
- Presión arterial (no bajar bruscamente).
- Temperatura (tratar fiebre).

3. **Evitar hipotensión y deshidratación.**

4. **Control de convulsiones** si aparecen.

5. **TAC sin contraste inmediata** antes de cualquier tratamiento.

5.2. Manejo específico del ACV isquémico

A. Trombolisis intravenosa (rt-PA, alteplasa):

- Indicación: ACV isquémico dentro de las **4,5 horas** desde el inicio de síntomas.
- Dosis: 0,9 mg/kg (máx. 90 mg) → 10% bolo, resto infusión 1 h.
- Contraindicaciones:

- TAC con hemorragia.
- PAS >185 mmHg o PAD >110 mmHg no controlable.
- Trombocitopenia o INR >1,7.
- Cirugía mayor o trauma reciente.
- Sospecha de endocarditis o disección aórtica.

B. Terapia endovascular (trombectomía mecánica):

- Indicada en oclusión de grandes vasos (ACM proximal, carótida interna).
- Ventana extendida hasta **24 horas** en centros especializados.

C. Control de la presión arterial:

- No tratar salvo PAS >220 mmHg o PAD >120 mmHg, salvo si es candidato a trombolisis (objetivo <185/110).

D. Antiagregación:

- **Aspirina 160–325 mg VO** dentro de las 24–48 horas posteriores (si no se realizó trombolisis).

E. Prevención secundaria:

- Control de HTA, DM y dislipidemia.
- Suspender tabaco.
- Anticoagulación oral en FA (apixabán, rivaroxabán, warfarina).
- Estatinas en todos los pacientes con ACV aterotrombótico.

5.3. Manejo específico del ACV hemorrágico

A. Medidas iniciales:

- Control estricto de PA (mantener PAS <140 mmHg).

- Suspender anticoagulantes y revertir con vitamina K o antídotos específicos.
- Manejo de PIC: elevar cabecera, manitol o solución salina hipertónica si hay signos de herniación.
- Evitar hiperglicemia y fiebre.

B. Tratamiento quirúrgico:

- Indicado en hematomas grandes, compresión de tronco o hidrocefalia aguda (derivación ventricular externa).
- En HSA por aneurisma: clipaje o embolización precoz.

C. Rehabilitación precoz:

Movilización temprana, fonoaudiología, kinesioterapia y apoyo psicológico.

6. Complicaciones

- Edema cerebral y herniación.
 - Convulsiones post-ACV.
 - Neumonía aspirativa.
 - TVP o embolia pulmonar (por inmovilidad).
 - Depresión post-ictus.
 - Recaída o nuevo ACV.
-

7. Pronóstico

Depende del tipo, extensión y rapidez del tratamiento.

- **ACV isquémico leve o lacunar:** buena recuperación.
- **ACV masivo o hemorrágico:** mortalidad alta (30–50%).

- La rehabilitación precoz mejora significativamente la independencia funcional.

Escala pronóstica: NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale).

Prevención secundaria: control de factores de riesgo y adherencia a tratamiento.

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. “**Déficit neurológico focal súbito**” → pensar primero en ACV.
2. El **TAC sin contraste** debe realizarse siempre antes de trombolisis.
3. La **trombolisis IV con rt-PA** tiene una ventana de **4,5 horas**.
4. El **ACV hemorrágico** no se trata con aspirina ni anticoagulantes.
5. En **EUNACOM**, suelen preguntar cómo diferenciar isquemia vs hemorragia y las indicaciones de trombolisis.
6. El control de presión arterial y glicemia previene recurrencias.
7. El **manejo multidisciplinario precoz** mejora el pronóstico.

Errores comunes:

- Iniciar aspirina antes de confirmar con TAC.
 - No medir glicemia antes del diagnóstico.
 - Bajar bruscamente la presión arterial.
 - No sospechar FA como causa de embolia.
 - Omitir rehabilitación temprana.
-

9. Resumen final (6 ideas clave)

1. El **ACV** es un déficit neurológico focal súbito causado por isquemia o hemorragia cerebral.
2. El **ACV isquémico** representa el 85% de los casos y puede tratarse con **trombolisis IV dentro de las 4,5 horas**.
3. El **TAC sin contraste** es esencial para distinguir entre isquemia y hemorragia.
4. El **ACV hemorrágico** requiere control estricto de PA y manejo neuroquirúrgico si corresponde.
5. El manejo agudo se resume en: **evaluar ABC, TAC urgente, controlar PA y considerar trombolisis**.
6. En **EUNACOM**, las preguntas más frecuentes abordan diagnóstico diferencial, indicaciones de trombolisis y manejo inicial.